27.222.193-6

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Amanda Trinidad Valencia Severino		Sexo	F	✓	M
Fecha Nacimiento	02/3/2020	Edad actual	años	meses	País natal:	Chile
Domicilio actual:	Sto Aldea #604 V. los Alamos			Teléfono	953381400	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☐ lee ☐ escribe ☐			
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐			
Escolaridad actual:	Especial	Establecimiento	Liceo Mixto, Básico S.F.			

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Paola Severino.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Beatriz Sánchez	Nombre:
Rol/cargo: Ed. Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Diagnóstico de T.E.A.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología: T.E.A	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SÍ ☐ NO | Peso: 365 | Talla: 47,7

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto: La madre dilató hasta aproximadamente, la niña venía con taquicardia fetal; por lo cual se realizó cesárea. 38 semanas.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	[✓ Sí]	No	Traumatismos	Sí	[✓ No]	Encefalitis	Sí	[✓ No]
Obesidad	Sí	[✓ No]	Intoxicación	Sí	[✓ No]	Meningitis	Sí	[✓ No]
Fiebre alta	Sí	[✓ No]	Enfermedad respiratoria	Sí	[✓ No]	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	[✓ No]	Asma	Sí	[✓ No]			
Hospitalizaciones	Sí	[✓ No]	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	[✓ Sí]	No	Vacunas	[✓ Sí]	No

Observaciones: La niña a los días al nacer evidencia bajo peso. La madre tuvo que dar leche materna libre demanda a la niña cada 2 hrs.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3 m	Se sienta sólo/a: 8 m	Camina sin apoyo: 1 año
Primeras palabras: 1 año	Primeras frases: 1 año	Se viste solo/a: 3 años
Controla esfínter vesical Diurno: 3 a Nocturno: 3 a	Controla esfínter anal Diurno: 3 a Nocturno: 3 a	

Observaciones: Evidenció dificultades para dejar los pañales a pesar del trabajo que se realizaba con la niña para motivarla.

En su actividad motora general se aprecia:
☑ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	[✓ Sí]	No	Caídas frecuentes	Sí	[✓ No]	Dominancia lateral	[✓ Sí]	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	[✓ Sí]	No	Prensión	[✓ Sí]	No	Pinza	[✓ Sí]	No
Ensarta	[✓ Sí]	No	Dibuja	[✓ Sí]	No	Escribe	[✓ Sí]	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	[✓ Sí]	No	Manipula y Explora objetos	[✓ Sí]	No
Demanda objetos y compañía	[✓ Sí]	No	Comprende prohibiciones	[✓ Sí]	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	[✓ Sí]	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	[✓ Sí]	No

Observaciones:
Sin observaciones relevantes.

2

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	[✓ Sí]	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	[✓ Sí]	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	[✓ No]	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	[✓ Sí]	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	[✓ No]	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	[✓ Sí]	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	[✓ No]	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	[✓ No]
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	[✓ Sí]	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	[✓ No]
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	[✓ No]	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	[✓ No]
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	[✓ No]	La pronunciación oral es adecuada	Sí	[✓ No]
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	[✓ No]	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	[✓ No]

Observaciones:
Sin observaciones relevantes.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma
☑ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	[✓ Sí]	No	Emite/produce frases	[✓ Sí]	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	[✓ Sí]	No	Relata experiencias	[✓ Sí]	No
Emite palabras/produce señas	[✓ Sí]	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	[✓ No]

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones simples	[✓ Sí]	No
Identifica personas	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones complejas	[✓ Sí]	No
Comprende conceptos abstractos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones grupales	[✓ Sí]	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	[✓ Sí]	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	[✓ Sí]	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):
no manifiesta pérdida del lenguaje.

Observaciones:
Sin observaciones significativos.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	[✓ No]	Se relaciona en forma colaborativa	[✓ Sí]	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	[✓ No]	Respeta normas sociales	[✓ Sí]	No
Participa en actividades grupales	Sí	[✓ No]	Respeta normas escolares	[✓ Sí]	No
Opta por trabajo individual	[✓ Sí]	No	Muestra sentido del humor	[✓ Sí]	No
Presenta lenguaje ecolálico	[✓ Sí]	No	Movimientos estereotipados	[✓ Sí]	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	[✓ Sí]	No	Pataletas frecuentes	[✓ Sí]	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces: ☑ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☑ natural ☐ desmesurada	**Personas extrañas:** ☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

3

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	[✓ Sí]	No	Trastorno motor	Sí	[✓ No]
Epilepsia	Sí	[✓ No]	Problema bronco-respiratorio	[✓ Sí]	No
Problemas cardiacos	Sí	[✓ No]	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	[✓ No]
Paraplejia	Sí	[✓ No]	Trastorno emocional	Sí	[✓ No]
Pérdida auditiva	Sí	[✓ No]	Trastorno conductual	Sí	[✓ No]
Pérdida visual	Sí	[✓ No]	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Para el asma. medicamento Fluticasona.

Alimentación: ☑ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme:

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor

Duerme: ☑ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:

Sin observación relevante.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Paola Severino	Madre	31	Univ.	Trab. Social
2. Orieta Pona	Abuela M.	57	4° M.	Dueña de Casa
3. Lucas Severino	Tío M	17	4° M.	Estudiante.
4. Patricio Severino	Tío M	27	I.E.S.	Vendedor.
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Madre epiléptica en tratamiento y T.E.A.

Observaciones:

solo las observaciones antes mencionadas

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4 años	Asistió a jardín infantil	[✓ Sí] No
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:	

Motivo de los cambios: Cambio de domicilio.

Ha repetido curso/s	Sí	[✓ No]	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	1° bás		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	[✓ No]	**Dificultad para participar**	[✓ Sí]	No	**Conducta disruptiva**	Sí	[✓ No]
Asiste regularmente	[✓ Sí]	No	Asiste con agrado	[✓ Sí]	No	Apoyo familiar en tareas	[✓ Sí]	No	Amigos (as)	Sí	[✓ No]

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) ……………………………………

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra ……………………………………

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ……………………………………
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s)……………………

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales ……………………………………

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Presenta trastorno de Integración sensorial desde el 2023 (neurólogo).
. Sospecha de mutismo selectivo
. La madre de la niña sufrió VIF por lo cual se separó del padre de la niña.

5